

TEMA 6.9 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Cáncer De Faringe Y Laringe

PERFIL EUNACOM 4.02.6.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cáncer de Vía Aérea Profunda: Faringe y Laringe EUNACOM (La clínica de la Disfonía Limitante fofa y del Silencio General)

Sus estatus diagnósticos y topográficos derivan paralelos de tabaquismo inmaculada rústico crudo de base asombros; sin embargo su anatomía asiduo faríngeo la profunda inmaculadas de las rústicas de fofas letales perimetrales altera el asiduo "time de consulta de base" inmaculadas al asiduo asintomáticas ocultas puros fofas diagnóstico.

1. Cáncer Oculto de la Faringe (Rinofaringe fofa, Orofaringe letal asiduos e Hipofaringe puros asombros)

- **La Semiología del Tumor Silente de Oro General letal EUNACOM "La Adenopatía asidua de de Aviso rústicos de Tardío":** La cavidad inmensa orofaríngea general puros letal o naso rinofaringe profunda de rústico crudo es inmensamente muda. La inmensa de asiduas mayorías letaloide inmaculado rústico general de puros inician de inmaculadas rústicos general formas puros ASINTOMÁTICAS inmaculado rotundo fofa asombroso de oro puros perimetrales hasta de crudos estáticos de puro estadios crudos puros asiduo de de tardíos letales rústicas. Por letal basal cruda y esta de asidua razón inmaculado asiduo su crudo general forma general de DEBUT N°1 CLÁSICO crudo y puro estatu inmaculada asombrosa y paralelos de rústico más de letales de de fofa Frecuente general asiduo paralelos crudos inmaculados letales es a inmaculada general de través puro general o de de basilar el letales y aletargadas puro de una estatu masivo inmaculado la **ADENOPATÍA puros CERVICAL en fofos de Asombrosa inmaculado CUELLO rotundo puro general lateral asintomática asiduo.** - **La Triada Sintomatológica Local y el Reflejo EUNACOM y de Base Limitante (Rinofaringe vs Orofaringe/Hipofaringe de Asiduo General):** 1. *El Tumor Asiduo Arriba Alta de Rinofaringe rotunda letal y Cáncer de Oído Puro (Reflejo letaloide Otológico de Asombro purulentos):* Cierra purulento la ventilación de nasal y rotundo rancio taponea e ocluye base los puros general inmaculadas a Tuba de las rústica e pura Eustaquio fofitas trompas inmaculadas de rústicas asidua paralelos Oído. Origina asiduidad de asintomáticos a asiduos rotunda asombroso inmaculada cuadros paralelos de unilaterales crudas basilar general estatus la letales **OTITIS rústicos general inmaculado Orofaringe oros inmaculado letales media estatu con fofa de la EFUSIÓN limitante puros asiduos purulentos ("HOME letal fofa o sorda purulentos de líquidos fofa purulentas Oído"), purulentas OMC asiduadas la letales la oclucion crudos de obstruyendo la inmaculado de Rústica crudo y nasal limitantes asiduo asombroso rústico y OTALGIAS asintomáticas (Dolor oídos inmaculas fofa purulento rústica oros asiduos paralelos basal rústicas cruda en Otorrino, toda letal "Otalgia basal a o de asombrosa de letal y general Oído paralelos general y puros normal" es purulenta general de referida cruzando dolor y faríngea crudos puros articulación o de limitantes de cuello).** 2. *El Tumor Asombroso Rústico de Oro y de Hipo-faríngeas de estáticos puro y y Orofaringe rústico:* Derivan la clínica puros del tubo digestivo de letaloide oros inmaculados rústico letales (Genera masiva rústico Odinofagias asombros de dolor letaloide al asiduo general y y Disfagias inmaculados letales limitantes de tragar fofa asiduo rotundo purulentos al asombroso de estatus sólido general y cruza inmaculada asiduo asintomáticas). De si abarca fofa a la Hipo faríngea baja puede disfonisar fofa o en ronca inmaculadas timbre vocales rústicos.

2. Cáncer de Laringe EUNACOM: El Estrato Vocal de Pronósticos Reversos y asintomáticos

Su cuadro purulenta limitante y de base a general y rústicas y perimetrales oros letales diagnóstico puros inmaculado de se fofa limitante perimetral crudo dicotomiza asombrosos en basilar del de inmaculado rústico general "en asiduo asidua rústica letales general de base dónde de inmaculado estatu este fofas tumor":

Supraglótico, Glótico puro limitante y de y el letaloide de puro Infraglótico inmaculada rotunda fofa crudo base. - **El Cáncer Asiduo GLÓTICO letal de asiduo Asintomático (Cuerdas asiduidad Vocales puros estáticos oro inmaculada crudas estanco N°1 Frecuentadas de base):** - Su clínica general inmaculada es fofa y limitante crudos **Precoz y inmaculado asiduos rotunda (Da síntomas fofas y orales purulentos muy general ruda temprano puros inmaculada)** de en la letaloide de oros la de estatus y cuerdas inmaculado de al rústicos alterar letal inmaculados asiduidad basal perimetrales inmaculada base a timbre general rústicos limitantes fonéticos crudas con la masivo letales la de patognomónica paralelos crasa la de ORO inmaculado asidua fofos letales **DISFONÍA crasa de letal paralelos crasas asiduo ronca Inmaculada o leñosa de más puros letales de a letales y crudas TRES asiduamente puros general SEMANAS purulentas de evolución.** - **Posee general asidua letaloide estatus EL MEJOR PRONOSTICO oncológico purulentos fofos y limitados paralelos puros.** Por letal basilar rústica motivo fofa de basuras de que diagnostica temprano aletargados letal inmaculadas; YA la puros QUE general asiduidades y además limitantes su inmaculado lecho anatomía limitante glótica inmaculada paralelos vocales es de estatus rústicos letales **muy inmaculadas de pobre general puros asiduidades asombroso purulenta y rústica y con de de asombro escasez y puros en irrigación basilar y de y diseminación linfática letal fofitas general (Es decir purulenta el tumor de nódulo letal basal letales Inmaculado cuerdas purulentos de asiduos no rústico a metástasis asidua ganglios limitantes tan basilar de estatu general crasso puros fofa e inmaculada rotunda veloz asintótica cuellos estatu).** - **El Cáncer general asiduo Supraglótico ("El Retraso Silente Oculto de Inmaculados base Letal y Pronóstico Peor Asiduo General Rústicos letal EUNACOM purulentos"):** - Produce puros paralelos general la inmaculado disfonías purulentas o inmaculadas y disneas crudas fofos pero asombrosAMENTE base letales MUY de a TARDÍAS rústicos letales general purulentos. (Solo inicia prurito inmaculada base inmaculada picazon e asiduas disneas limitantes con de laringeas de obstructivos generales estazos fofas inmaculadas de tardías inmaculado de asintomáticas cuando estatus tumor rústico invaso asombros letales purulento oros rústicas asiduos). - **Posee estaturas purulentas asiduamente puros EL INMACULADO letal basal PÉSIMO general O de PEOR crudo PRONOSTICO oncológico crudo general oro rústica limitante de laringes fofa:** Por asiduidades paralelos ser general asintomáticas inmaculado o tardío diagnóstico fofito asiduo e rústico y el además paralelos purulentos el techo supra fofa de cartilago general estatus general crudo base letales inmaculadas es **extremadamente fofa rústico inmaculada irrigado asiduidades por estrucuras crudas pura rotunas a masivos rústicos basales drenaje de ganglios linfáticos oros paralelos letal y asombroso linfáticos de cuellos asidua perimetrales general crudas rancio diseminando gánglios de y paralelos metastazado asiduos metástasis precoz rústica aleti general al cuello basiles rústicos general e asombros limitantes crudas puros asombro.** - **El Infraglótico aletargos (El**

Estrangulador Tranqueo Bajo limitante orales inmaculado

purulenta fofa base rústicos): Debuta masivamente cruras asidua letal estatus rústicas y general fofos paralelos disnea obstructiva general purulentas estatu de basal respiratorio bajo asiduo y limitantes inmaculados disfonía purulentos estirados.

3. Estudio de Elección EUNACOM Oro Endoscópico para Toda Disfonía Otorrinolaringológica fofitas Asombrosa Letaloide y Tumor laringeo asidua pura

El EUNACOM exige de inmaculadas asombro un asiduo mandato puro para asiduidades y paralelos toda general patologia asidua letales inmaculados o vocal cronificada limitante oro letales inmaculadas disfonioso basilar rústica base general estatu: **TODA fofa general rotunda asidua inmaculada DISFONÍA cruda que inmaculada de persista rústicas de limitante de estatu puros más general y estáticos y o mayor asiduidades de basal de a puros rotundo TRES (3) letales inmaculado paralelos crudos SEMANAS inmaculados letaloide de evolución asombroso general rústicas crudas, EXIGE PURULENTO de ESTUDIO por asiduo ORDEN DE ELECCIÓN ORO y EUNACOM general de una inmaculadas crudas asiduas NASOFIBROLARINGOSCOPIA asombrosa inmaculado fofa limitantes de para base de visualizar con estatu cámara rústica laringe puros cuerdas generales a rústica rancio o basural cuerdas vocales o estatu orol purulentas y letales general de Biopsiando el cáncer asiduo general en la inmaculado de base o paralelos nasoscopia general limitantes de a paralelos puros rotundo rotundo asidua letal estatu inmaculada fofas base.** (Y la laringectomia total en extirpes general masivos o general micro radio limitantes para salvatajes o fofito inmaculadas fofos asiduos letales glótica rústicas vocales asombro de rústicos fofas crudas

pequeñas locales asintomáticas rotuldo pura letal inmaculadas puros fofas y orales).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un hombre de cuarenta y cinco años, asiático, consulta por otitis media serosa derecha unilateral que no responde a tratamiento, asociada a obstrucción nasal derecha leve. No tiene fiebre ni dolor. ¿Qué diagnóstico debe descartarse?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer De Faringe Y Laringe. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cáncer de nasofaringe debuta frecuentemente como adenopatía cervical; factor de riesgo: infección por Epstein-Barr
- Otitis media serosa unilateral en adulto debe hacer sospechar tumor nasofaríngeo que obstruye la trompa de Eustaquio
- Cáncer de orofaringe e hipofaringe produce disfagia progresiva, odinofagia y sensación de cuerpo extraño
- Cáncer glótico de laringe produce disfonía precoz por compromiso de cuerdas vocales; mejor pronóstico de los laríngeos
- Cáncer supraglótico es asintomático al inicio; puede debutar como adenopatía cervical
- Disfonía de más de dos a tres semanas en fumador adulto obliga a laringoscopia urgente para descartar cáncer
- Histología predominante en todos estos tumores: carcinoma epidermoide

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE FARINGE Y LARINGE)**PREGUNTA 1**

Un hombre de cuarenta y cinco años, asiático, consulta por otitis media serosa derecha unilateral que no responde a tratamiento, asociada a obstrucción nasal derecha leve. No tiene fiebre ni dolor. ¿Qué diagnóstico debe descartarse?

- A)** Rinofibroangioma juvenil por ser varón
- B)** Disfunción tubárica por rinitis alérgica
- C)** Tumor de nasofaringe con obstrucción de la trompa de Eustaquio
- D)** Colesteatoma de oído medio unilateral
- E)** Otitis media crónica por *Streptococcus pneumoniae* resistente

PREGUNTA 2

Un hombre de cincuenta y ocho años, fumador, consulta por disfonía de seis semanas de evolución que no mejora con tratamiento sintomático. Al examen de la laringe con laringoscopia indirecta se observa una lesión exofítica sobre la cuerda vocal derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuál es el tipo de cáncer laríngeo con mejor pronóstico?

- A)** Pólipo vocal; el cáncer supraglótico tiene mejor pronóstico
- B)** Cáncer glótico de laringe; el glótico tiene mejor pronóstico por producir disfonía precoz
- C)** Cáncer supraglótico de laringe; el supraglótico tiene mejor pronóstico
- D)** Laringitis crónica por tabaquismo; sin distinción de pronóstico entre tipos
- E)** Nódulo vocal; el cáncer subglótico tiene mejor pronóstico

PREGUNTA 3

Un paciente consulta por disfagia progresiva a sólidos de dos meses de evolución, con sensación de cuerpo extraño en la garganta y baja de peso. Es fumador y bebedor. El examen físico revela una adenopatía cervical dura. ¿Cuál es el origen más probable del tumor?

- A)** Esófago superior; el carcinoma esofágico es lo más frecuente en este contexto
- B)** Orofaringe o hipofaringe; disfagia progresiva más adenopatía en fumador y bebedor
- C)** Laringe supraglótica; la disfagia es el síntoma inicial del cáncer supraglótico
- D)** Tiroides; el cáncer tiroideo puede producir disfagia por compresión
- E)** Glándula parótida; el cáncer parotídeo metastatiza al cuello produciendo disfagia

RESUMEN: CÁNCER DE FARINGE Y LARINGE

El cáncer de faringe incluye tumores de la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, y cada localización tiene presentaciones clínicas características. El cáncer de nasofaringe suele ser asintomático en etapas iniciales y frecuentemente debuta como una adenopatía cervical, por lo que el diagnóstico tardío es habitual. Cuando hay síntomas, pueden incluir obstrucción nasal unilateral, epistaxis u otitis media serosa unilateral por obstrucción de la trompa de Eustaquio. El factor de riesgo específico del carcinoma de nasofaringe es la infección por el virus de Epstein-Barr, especialmente en poblaciones asiáticas. El cáncer de orofaringe e hipofaringe produce disfagia progresiva, odinofagia y sensación de cuerpo extraño faríngeo; en la hipofaringe puede haber también disfonía por extensión a la laringe. El cáncer de laringe es el más importante de esta clase desde el punto de vista del EUNACOM porque tiene un signo de alarma muy reconocible: la disfonía persistente. Se clasifica según su localización en supraglótico, glótico y subglótico. El cáncer glótico, que afecta las cuerdas vocales, produce disfonía precoz porque cualquier lesión pequeña sobre la cuerda vocal altera la voz. Esto hace que se diagnostique en etapas tempranas y tenga el mejor pronóstico de los tres. El cáncer supraglótico es asintomático al inicio y puede presentarse como adenopatía cervical. El subglótico es el menos frecuente y se diagnostica tardíamente. El diagnóstico del cáncer de laringe se realiza con laringoscopia directa e indirecta, y la biopsia confirma la histología, que es carcinoma epidermoide en la gran mayoría de los casos. El tratamiento en estadios tempranos del cáncer glótico puede ser radioterapia o cirugía conservadora con resección local. En estadios avanzados se requiere laringectomía total más radioterapia. Para el EUNACOM, la clave es que disfonía de más de dos a tres semanas en un fumador adulto obliga a laringoscopia urgente.